JEU DE 52 CARTES + 2 JOKERS · ÉTUDIANTS IPA, MENTION PATHOLOGIES CHRONIQUES STABILISÉES, PRÉVENTION ET POLYPATHOLOGIES COURANTES EN SOINS PRIMAIRES

Raisonnement clinique IPA · Pathologies chroniques stabilisées

Un jeu de 52 cartes pour la mention « Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires ». Chaque couleur correspond à une étape du raisonnement clinique, chaque valeur à une situation clinique suivie à travers un même patient. Chaque carte indique les compétences IPA qu'elle mobilise. Réunir les quatre cartes d'une valeur, c'est dérouler un raisonnement complet, du recueil des données à la coordination du parcours.

Les 4 couleurs = 4 étapes

♥	**Cœur — Recueillir** Anamnèse, écoute, contexte de vie
♦	**Carreau — Repérer & hypothèses** Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges
♣	**Trèfle — Vérifier** Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels
♠	**Pique — Agir & suivre** Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Les 13 valeurs = 13 situations

2	Diabète de type 2 : pied diabétique
3	Diabète de type 1 : hypoglycémies
4	Maladie coronaire stable
5	Insuffisance cardiaque
6	Artériopathie des membres inférieurs
7	AVC : prévention secondaire
8	Insuffisance respiratoire chronique
9	Maladie d'Alzheimer : repérage et suivi
10	Maladie de Parkinson
V	Épilepsie et projet de grossesse
D	Anticoagulants oraux
R	Polymédication et iatrogénie
A	Patient polypathologique : parcours

Anatomie d'une carte

Vignette (situation du patient, qui évolue d'une couleur à l'autre) · **Question** posée au joueur · **Repères attendus**, lus uniquement par celui qui pose la question pour valider la réponse. Les repères ne sont pas exhaustifs : une argumentation pertinente non listée est valorisée.

Mode 1 · Le Carré clinique

3 à 6 joueurs · 45 à 60 min

1. Distribuer 6 cartes par joueur ; le reste forme la pioche.
2. À son tour, un joueur demande à un autre une carte précise pour avancer un carré (« le Trèfle de l'insuffisance cardiaque »).
3. Si l'autre la possède, il lit la vignette et la question ; le demandeur répond. Réponse validée au regard des repères → il prend la carte et rejoue. Sinon, ou si la carte n'est pas en jeu, il pioche et la main passe.
4. Carré complet : le joueur le pose et présente en 2 minutes une **synthèse orale** du raisonnement (recueil → hypothèses → vérification → action) : **4 points**. +1 point s'il le relie à une autre thématique (AOMI et pied diabétique, anticoagulants et polymédication…).
5. Fin de partie quand la pioche est vide : le plus de points l'emporte.

Les jokers

Drapeau rouge et **Leadership & recherche** remplacent une carte manquante d'un carré, à condition de relever le défi inscrit dessus.

Mode 2 · Le Fil rouge

Travaux dirigés · groupes de 4 à 8 · 20 min par cas

L'animateur extrait les 4 cartes d'une situation et les révèle dans l'ordre ♥ ♦ ♣ ♠. Le groupe raisonne à voix haute à chaque étape avant de découvrir la suivante, puis compare avec les repères.

Mode 3 · Le Tirage éclair

Révision en binôme · 10 à 15 min

Mélanger, tirer une carte, lire la vignette et la question ; le partenaire répond en 1 minute. Comparer aux repères, puis inverser les rôles.

Pistes de débriefing

- Hiérarchisation des hypothèses, drapeaux rouges
- Biais cognitifs : ancrage, fermeture prématurée
- Place du patient : préférences, littératie, décision partagée
- Cadre d'exercice IPA : ce qui relève de l'IPA, de la concertation, de l'orientation

Impression : A4, recto verso (retournement bord long), échelle 100 %, papier 250 à 300 g/m² ; découper le long des repères de coupe. Pages impaires = faces, pages paires = dos.
Avertissement : contenus fondés sur les recommandations connues en octobre 2026 (HAS, sociétés savantes, référentiels de la mention), sans vérification en ligne carte par carte ; les cas sont illustratifs. Les conduites thérapeutiques s'entendent dans le cadre des protocoles et de la réglementation en vigueur. À vérifier et actualiser par l'équipe pédagogique avant usage.

MENTION PATHOLOGIES CHRONIQUES STABILISÉES, PRÉVENTION ET POLYPATHOLOGIES COURANTES EN SOINS PRIMAIRES

Compétences et situations

La mention PCS couvre le suivi de patients atteints de pathologies chroniques stabilisées (diabète, insuffisance cardiaque, maladie coronaire, artériopathie, AVC, insuffisance respiratoire chronique, maladies d'Alzheimer et de Parkinson, épilepsie), la prévention et la prise en charge des polypathologies courantes en soins primaires.

Les 6 compétences IPA mobilisées

Code	Compétence	Où dans le jeu
C1	Évaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées	♥ ♦ ♣
C2	Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé	♣ ♠
C3	Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique	♦ ♠
C4	Organiser les parcours de soins et de santé en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés	♠
C5	Mettre en place et conduire des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques en exerçant un leadership clinique	Joker 2, repères ♠
C6	Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques	Joker 2, débriefing

Chaque carte porte en en-tête les compétences qu'elle mobilise en priorité. Les compétences C5 et C6 sont travaillées avec le joker « Leadership & recherche » et lors du débriefing.

Les 13 situations cliniques

2	**Diabète de type 2 : pied diabétique** M. D., 67 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, vit seul. Lors de son suivi, il dit « ne plus bien sentir ses pieds ».
3	**Diabète de type 1 : hypoglycémies** Léa, 24 ans, diabétique de type 1 sous pompe à insuline et capteur de glucose, rapporte des malaises nocturnes depuis qu'elle a repris la course à pied.
4	**Maladie coronaire stable** M. C., 61 ans, a eu un infarctus traité par angioplastie il y a un an. Il vient pour son suivi semestriel.
5	**Insuffisance cardiaque** Mme I., 78 ans, insuffisante cardiaque à fraction d'éjection réduite, vit avec son mari. Elle a été hospitalisée il y a un mois pour une décompensation.
6	**Artériopathie des membres inférieurs** M. A., 64 ans, fumeur et diabétique, a des douleurs au mollet droit à la marche, qui cèdent à l'arrêt.
7	**AVC : prévention secondaire** Mme V., 70 ans, rentre à domicile 3 semaines après un AVC ischémique, avec une légère faiblesse du bras droit.
8	**Insuffisance respiratoire chronique** M. B., 74 ans, BPCO sévère sous oxygène à domicile, ancien fumeur, est vu après une exacerbation.
9	**Maladie d'Alzheimer : repérage et suivi** Mme A., 77 ans, vient avec sa fille, inquiète de ses oublis : rendez-vous manqués, factures impayées.
10	**Maladie de Parkinson** M. P., 72 ans, parkinsonien depuis 8 ans, signale des « blocages » de plus en plus fréquents et deux chutes.
V	**Épilepsie et projet de grossesse** Sofia, 29 ans, épileptique, traitée par valproate depuis l'adolescence, vient pour son suivi. Elle a un projet de grossesse.
D	**Anticoagulants oraux** M. F., 81 ans, sous apixaban pour une FA, vient pour son renouvellement. Ses gencives saignent.
R	**Polymédication et iatrogénie** Mme M., 85 ans, prend 11 médicaments. Elle est plus somnolente et a chuté la semaine dernière.
A	**Patient polypathologique : parcours** M. G., 76 ans, diabétique, insuffisant cardiaque et en MRC stade 3, vit seul. Il a été hospitalisé trois fois cette année.

2 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Diabète de type 2 : pied diabétique

Compétences IPA : C1

> *M. D., 67 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, vit seul. Lors de son suivi, il dit « ne plus bien sentir ses pieds ».*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Ancienneté et équilibre du diabète (HbA1c), autres complications
- Symptômes : paresthésies, douleurs, claudication
- Antécédents de plaie, d'ulcération ou d'amputation
- Chaussage, hygiène, capacité à examiner ses pieds (vue, souplesse)
- Tabac, isolement, recours au pédicure-podologue

Raisonnement clinique · IPA PCS

♥ 2

2 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Diabète de type 2 : pied diabétique

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. D., 67 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, vit seul. Lors de son suivi, il dit « ne plus bien sentir ses pieds ».

> *Monofilament non perçu sur 2 sites à droite, pouls pédieux faibles, hyperkératose sous la tête du 1er métatarsien.*

? Comment gradez-vous le risque podologique ?

REPÈRES ATTENDUS

- Neuropathie (monofilament) + artériopathie suspectée + zone d'hyperappui
- Grade 0 : pas de neuropathie ; grade 1 : neuropathie isolée
- Grade 2 : neuropathie + AOMI et/ou déformation → au moins grade 2 ici
- Grade 3 : antécédent d'ulcération chronique ou d'amputation

Raisonnement clinique · IPA PCS

♦ 2

2 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Diabète de type 2 : pied diabétique

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. D., 67 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, vit seul. Lors de son suivi, il dit « ne plus bien sentir ses pieds ».

> *Il n'a pas de plaie. Il fume 10 cigarettes par jour.*

? Quels examens complètent votre évaluation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Index de pression systolique (IPS) : < 0,90 = AOMI ; > 1,30 = artères incompressibles
- Écho-doppler artériel si IPS anormal ou ininterprétable
- Inspection complète : espaces interorteils, ongles, mycoses
- Bilan du diabète : HbA1c, fonction rénale, rétinopathie

Raisonnement clinique · IPA PCS

♣ 2

2 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Diabète de type 2 : pied diabétique

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. D., 67 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, vit seul. Lors de son suivi, il dit « ne plus bien sentir ses pieds ».

> *Risque de grade 2 confirmé, IPS droit à 0,82.*

? Quel plan de soins proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- ETP : auto-examen quotidien, hygiène, jamais pieds nus, conduite à tenir devant une plaie
- Soins de pédicurie-podologie pris en charge (grades 2 et 3), chaussage adapté
- Arrêt du tabac, marche régulière, optimisation des facteurs de risque
- Avis vasculaire ; examen des pieds à chaque consultation
- Toute plaie = consultation urgente en centre spécialisé du pied diabétique

Raisonnement clinique · IPA PCS

♠ 2

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

3 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Diabète de type 1 : hypoglycémies

Compétences IPA : C1

Léa, 24 ans, diabétique de type 1 sous pompe à insuline et capteur de glucose, rapporte des malaises nocturnes depuis qu'elle a repris la course à pied.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Malaises : horaires, symptômes, resucrage, aide d'un tiers
- Données du capteur : temps dans la cible, temps sous 0,70 g/L
- Débits de base, bolus, adaptation à l'effort
- Horaires de l'activité physique, alimentation, alcool
- Connaissances et peur des hypoglycémies

3 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Diabète de type 1 : hypoglycémies

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Léa, 24 ans, diabétique de type 1 sous pompe à insuline et capteur de glucose, rapporte des malaises nocturnes depuis qu'elle a repris la course à pied.

Capteur : 8 % du temps sous 0,70 g/L, surtout 2 à 5 heures après les entraînements du soir.

? Comment interprétez-vous ces données ?

REPÈRES ATTENDUS

- Hypoglycémies nocturnes retardées après l'effort
- Objectifs consensuels : < 4 % du temps sous 0,70 g/L, < 1 % sous 0,54 g/L, > 70 % dans la cible (0,70–1,80 g/L)
- Causes : débit basal non réduit, absence de collation, alcool éventuel
- Risque : hypoglycémies non ressenties puis sévères

3 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Diabète de type 1 : hypoglycémies

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Léa, 24 ans, diabétique de type 1 sous pompe à insuline et capteur de glucose, rapporte des malaises nocturnes depuis qu'elle a repris la course à pied.

Elle dit ne plus sentir certaines hypoglycémies.

? Que recherchez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Non-perception des hypoglycémies (score de Gold ou de Clarke)
- Autres causes : insuffisance rénale, insuffisance surrénale, maladie cœliaque
- HbA1c, fonction rénale ; TSH selon le contexte
- Retentissement : conduite automobile, sommeil, anxiété

3 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Diabète de type 1 : hypoglycémies

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Léa, 24 ans, diabétique de type 1 sous pompe à insuline et capteur de glucose, rapporte des malaises nocturnes depuis qu'elle a repris la course à pied.

Léa veut continuer à courir le soir.

? Quel plan co-construisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Adaptation à l'effort : débit basal temporaire réduit, collation, ajustement des bolus, selon le protocole du diabétologue
- Alarmes du capteur ; resucrage par 15 g de glucides ; glucagon disponible, entourage formé
- ETP : prévention, reconnaissance, règles de conduite automobile
- Analyse des données à 2–4 semaines
- Coordination avec l'équipe de diabétologie

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

4 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Maladie coronaire stable

Compétences IPA : C1

M. C., 61 ans, a eu un infarctus traité par angioplastie il y a un an. Il vient pour son suivi semestriel.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Douleur thoracique d'effort, dyspnée, palpitations, malaises
- Observance et tolérance : antiagrégants, statine, bêtabloquant, IEC
- Tabac, PA, LDL-c, glycémie, poids, activité physique
- Retour au travail, sexualité, humeur (dépression post-infarctus)
- Réadaptation cardiaque suivie ou non

Raisonnement clinique · IPA PCS

♠ 4

4 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Maladie coronaire stable

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. C., 61 ans, a eu un infarctus traité par angioplastie il y a un an. Il vient pour son suivi semestriel.

Il a repris « quelques cigarettes ». LDL-c : 0,95 g/L. Il a arrêté sa statine à cause de douleurs musculaires.

? Quels problèmes et quels risques identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Prévention secondaire non optimale : tabac, LDL-c hors cible
- Cible ESC à très haut risque : LDL-c < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %
- Myalgies : intolérance réelle ou effet nocebo à explorer
- Risque élevé de récidive ; dépression à rechercher

Raisonnement clinique · IPA PCS

♦ 4

4 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Maladie coronaire stable

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. C., 61 ans, a eu un infarctus traité par angioplastie il y a un an. Il vient pour son suivi semestriel.

Pas de douleur thoracique. Myalgies diffuses, sans faiblesse musculaire.

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- CPK (myalgies), TSH (l'hypothyroïdie favorise les myalgies)
- Bilan lipidique, HbA1c, créatinine, transaminases
- ECG de suivi, PA, IMC, tour de taille
- PHQ-9 ; mesure du CO expiré

Raisonnement clinique · IPA PCS

♣ 4

4 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Maladie coronaire stable

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. C., 61 ans, a eu un infarctus traité par angioplastie il y a un an. Il vient pour son suivi semestriel.

M. C. accepte de « revoir les choses ».

? Quel plan de suivi proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Arrêt du tabac : substituts nicotiniques, entretien motivationnel
- Réintroduction d'une statine (autre molécule ou dose) avec le cardiologue ; ézétimibe si besoin
- Activité physique ; réadaptation cardiaque si non faite
- ETP : conduite à tenir en cas de douleur thoracique (15), observance des antiagrégants
- Suivi partagé avec le cardiologue et le médecin traitant

Raisonnement clinique · IPA PCS

♥ 4

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

5 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Insuffisance cardiaque

Compétences IPA : C1

> *Mme I., 78 ans, insuffisante cardiaque à fraction d'éjection réduite, vit avec son mari. Elle a été hospitalisée il y a un mois pour une décompensation.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Dyspnée (classe NYHA), orthopnée, œdèmes, évolution du poids
- Traitements, tolérance (vertiges, toux, hypotension), observance
- Régime peu salé, apports hydriques, pesée
- Comorbidités : FA, MRC, diabète, anémie
- Autonomie, entourage, compréhension de la maladie

5 ♥

5 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Insuffisance cardiaque

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme I., 78 ans, insuffisante cardiaque à fraction d'éjection réduite, vit avec son mari. Elle a été hospitalisée il y a un mois pour une décompensation.

> *Elle a pris 2,5 kg en 4 jours, dort avec trois oreillers ; œdèmes des chevilles.*

? Quelle hypothèse ? Quels signes de gravité recherchez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Décompensation cardiaque débutante
- Facteurs déclenchants : écart de sel, AINS, infection, FA rapide, arrêt de traitement
- Gravité : dyspnée de repos, SpO_2 basse, hypotension, confusion, douleur thoracique
- Signe de gravité → orientation urgente

5 ♦

5 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Insuffisance cardiaque

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme I., 78 ans, insuffisante cardiaque à fraction d'éjection réduite, vit avec son mari. Elle a été hospitalisée il y a un mois pour une décompensation.

> *Pas de signe de gravité. PA 118/70, pouls irrégulier à 88/min, SpO_2 95 %.*

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- ECG : fibrillation atriale ?
- Ionogramme, créatinine et DFG (diurétiques, IEC, antialdostérone), NFS
- BNP ou NT-proBNP comparé à la valeur de référence
- Recherche du facteur déclenchant

5 ♣

5 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Insuffisance cardiaque

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme I., 78 ans, insuffisante cardiaque à fraction d'éjection réduite, vit avec son mari. Elle a été hospitalisée il y a un mois pour une décompensation.

> *Une FA est découverte ; la créatinine est stable.*

? Quelle conduite à tenir et quel suivi ?

REPÈRES ATTENDUS

- Adaptation du diurétique selon le protocole, avec le cardiologue
- FA : avis cardiologique, anticoagulation selon le score CHA_2DS_2-VASc
- Contrôle rapproché : poids, clinique, ionogramme sous quelques jours
- ETP : pesée quotidienne, signes d'alerte, régime peu salé
- Télésurveillance, programme de retour à domicile, coordination ville-hôpital

5 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

6 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Artériopathie des membres inférieurs

Compétences IPA : C1

> *M. A., 64 ans, fumeur et diabétique, a des douleurs au mollet droit à la marche, qui cèdent à l'arrêt.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Périmètre de marche, délai de récupération, douleurs de repos ou nocturnes
- Facteurs de risque : tabac (paquets-années), diabète, HTA, dyslipidémie
- Antécédents coronaires ou d'AVC
- Troubles trophiques, plaies, retentissement sur la vie quotidienne

6 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Artériopathie des membres inférieurs

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. A., 64 ans, fumeur et diabétique, a des douleurs au mollet droit à la marche, qui cèdent à l'arrêt.

> *Périmètre de marche de 200 m ; pouls pédieux droit absent.*

? Quelle hypothèse ? Comment la confirmer ?

REPÈRES ATTENDUS

- Claudication intermittente évocatrice d'AOMI
- IPS < 0,90 = AOMI ; > 1,30 (diabète) → mesure de la pression d'orteil
- Différentiels : canal lombaire étroit, sciatique, arthrose
- AOMI = marqueur d'athérome diffus : chercher d'autres localisations

6 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Artériopathie des membres inférieurs

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. A., 64 ans, fumeur et diabétique, a des douleurs au mollet droit à la marche, qui cèdent à l'arrêt.

> *IPS droit : 0,72. Pas de plaie.*

? Quel bilan complémentaire ?

REPÈRES ATTENDUS

- Écho-doppler artériel des membres inférieurs
- Bilan lipidique, HbA1c, fonction rénale
- Autres localisations : ECG, auscultation carotidienne
- Stade de Leriche et Fontaine : stade II

6 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Artériopathie des membres inférieurs

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. A., 64 ans, fumeur et diabétique, a des douleurs au mollet droit à la marche, qui cèdent à l'arrêt.

> *L'AOMI est confirmée.*

? Quelle prise en charge proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Arrêt du tabac : priorité absolue
- Traitement médical (antiagrégant, statine, IEC) selon prescription ; équilibre du diabète
- Marche supervisée : au moins 30 min, 3 fois par semaine
- ETP : soin des pieds, signes d'alerte (douleur de repos, plaie, pied froid)
- Ischémie aiguë (pied froid, pâle, douloureux) = urgence

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

7 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

AVC : prévention secondaire

Compétences IPA : C1

> *Mme V., 70 ans, rentre à domicile 3 semaines après un AVC ischémique, avec une légère faiblesse du bras droit.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Déficits résiduels : moteurs, langage, déglutition, cognition, humeur
- Cause retenue (FA, athérome carotidien, petites artères) et traitements
- Facteurs de risque : HTA, diabète, tabac, alcool
- Autonomie, aides, entourage, conduite automobile
- Connaissance des signes d'alerte d'AVC

Raisonnement clinique · IPA PCS

7 ♥

7 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

AVC : prévention secondaire

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme V., 70 ans, rentre à domicile 3 semaines après un AVC ischémique, avec une légère faiblesse du bras droit.

> *PA en automesure : 152/90 mmHg. Elle se dit « fatiguée et triste ».*

? Quels problèmes repérez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Objectif tensionnel non atteint (cible habituelle < 130/80 après un AVC)
- Dépression post-AVC fréquente : PHQ-9
- Fatigue post-AVC, troubles cognitifs possibles (MoCA)
- Risque de récidive majoré

Raisonnement clinique · IPA PCS

7 ♦

7 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

AVC : prévention secondaire

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme V., 70 ans, rentre à domicile 3 semaines après un AVC ischémique, avec une légère faiblesse du bras droit.

> *Elle prend son traitement de façon irrégulière.*

? Quelles évaluations complètent le bilan ?

REPÈRES ATTENDUS

- Observance : entretien, pilulier, compréhension des traitements
- Bilan lipidique (LDL-c < 0,70 g/L après AVC athéromateux), HbA1c, créatinine
- Dépistage cognitif, troubles de la déglutition
- Spasticité, épaule douloureuse

Raisonnement clinique · IPA PCS

7 ♣

7 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

AVC : prévention secondaire

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme V., 70 ans, rentre à domicile 3 semaines après un AVC ischémique, avec une légère faiblesse du bras droit.

> *Mme V. veut « ne pas refaire d'AVC ».*

? Quel plan de soins proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Optimisation de la PA et du LDL-c avec le médecin, selon protocole
- ETP : signes d'alerte VITE (visage, inertie d'un membre, trouble de la parole, en urgence le 15)
- Rééducation : kinésithérapie, orthophonie, activité physique adaptée
- Soutien de l'humeur, avis médical
- Coordination neurologue et médecin traitant

Raisonnement clinique · IPA PCS

7 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

8 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Insuffisance respiratoire chronique

Compétences IPA : C1

M. B., 74 ans, BPCO sévère sous oxygène à domicile, ancien fumeur, est vu après une exacerbation.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Dyspnée (mMRC), toux, expectorations : couleur, volume
- Usage réel de l'oxygène (heures par jour, débit), tolérance
- Technique d'inhalation, observance
- Exacerbations et hospitalisations dans l'année
- Poids, activité, humeur, isolement

Raisonnement clinique · IPA PCS

♥ 8

8 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Insuffisance respiratoire chronique

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. B., 74 ans, BPCO sévère sous oxygène à domicile, ancien fumeur, est vu après une exacerbation.

Il utilise l'oxygène 8 heures par jour au lieu de 15. Il a perdu 4 kg en 3 mois.

? Quels problèmes repérez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Oxygénothérapie insuffisante : bénéfice si ≥ 15 h/jour
- Dénutrition probable : facteur pronostique péjoratif
- Exacerbations fréquentes
- Freins : bruit, gêne, peur, image de soi

Raisonnement clinique · IPA PCS

♦ 8

8 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Insuffisance respiratoire chronique

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. B., 74 ans, BPCO sévère sous oxygène à domicile, ancien fumeur, est vu après une exacerbation.

SpO_2 90 % sous 2 L/min au repos.

? Quelles évaluations réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Gaz du sang selon le protocole (hypercapnie ?)
- IMC, albuminémie, évaluation nutritionnelle
- Test de marche de 6 minutes si possible
- Anxiété-dépression (HAD), comorbidités cardiaques

Raisonnement clinique · IPA PCS

♣ 8

8 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Insuffisance respiratoire chronique

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. B., 74 ans, BPCO sévère sous oxygène à domicile, ancien fumeur, est vu après une exacerbation.

M. B. veut « continuer à jardiner ».

? Quel plan de soins proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Négocier ≥ 15 h/jour d'oxygène, matériel portable adapté
- Réhabilitation respiratoire, activité physique adaptée
- Prise en charge nutritionnelle
- Plan d'action écrit en cas d'exacerbation ; vaccinations à jour
- Sécurité (pas de flamme) ; coordination pneumologue et prestataire

Raisonnement clinique · IPA PCS

♠ 8

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

9 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Maladie d'Alzheimer : repérage et suivi

Compétences IPA : C1

Mme A., 77 ans, vient avec sa fille, inquiète de ses oublis : rendez-vous manqués, factures impayées.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Plainte : nature, ancienneté, évolution, avis de l'entourage
- Activités instrumentales : finances, téléphone, transports, médicaments
- Comportement, humeur, sommeil
- Médicaments (anticholinergiques, benzodiazépines), alcool
- Audition, vision

♠ 6

Raisonnement clinique · IPA PCS

9 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Maladie d'Alzheimer : repérage et suivi

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme A., 77 ans, vient avec sa fille, inquiète de ses oublis : rendez-vous manqués, factures impayées.

MMSE : 22/30. Elle s'est perdue une fois en voiture.

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Trouble neurocognitif probable avec retentissement sur l'autonomie
- Maladie d'Alzheimer ; forme vasculaire ou mixte
- Différentiels : dépression, confusion, iatrogénie, hypothyroïdie, carence en B12
- Danger immédiat : conduite automobile

♦ 6

Raisonnement clinique · IPA PCS

9 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Maladie d'Alzheimer : repérage et suivi

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme A., 77 ans, vient avec sa fille, inquiète de ses oublis : rendez-vous manqués, factures impayées.

Vous préparez la consultation mémoire.

? Quel bilan réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- NFS, ionogramme, calcémie, glycémie, TSH, albuminémie, fonction rénale
- Vitamine B12, folates selon le contexte
- Imagerie cérébrale (IRM) selon prescription
- Tests complémentaires (5 mots, horloge), humeur, autonomie

♣ 6

Raisonnement clinique · IPA PCS

9 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Maladie d'Alzheimer : repérage et suivi

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme A., 77 ans, vient avec sa fille, inquiète de ses oublis : rendez-vous manqués, factures impayées.

Maladie d'Alzheimer au stade léger.

? Quel plan de soins et d'accompagnement ?

REPÈRES ATTENDUS

- Annonce et information adaptées, plan de soins et d'aides
- Sécurité : conduite, gestion des médicaments et des finances
- Équipe spécialisée Alzheimer, activité physique, stimulation
- Soutien de l'aidante : plateforme de répit, formation
- Anticiper : protection juridique, directives anticipées ; suivi tous les 6 mois

♥ 6

Raisonnement clinique · IPA PCS

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

10 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Maladie de Parkinson

Compétences IPA : C1

> *M. P., 72 ans, parkinsonien depuis 8 ans, signale des « blocages » de plus en plus fréquents et deux chutes.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Blocages, dyskinésies : horaires par rapport aux prises
- Horaires réels de la lévodopa, lien avec les repas protéinés
- Chutes, freezing, malaises au lever
- Signes non moteurs : constipation, urines, sommeil, hallucinations, humeur
- Retentissement pour le patient et son aidante

10 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Maladie de Parkinson

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. P., 72 ans, parkinsonien depuis 8 ans, signale des « blocages » de plus en plus fréquents et deux chutes.

> *Les blocages surviennent environ 3 heures après chaque prise.*

? Comment interprétez-vous ces symptômes ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fluctuations de fin de dose : maladie avancée
- Chutes multifactorielles : freezing, instabilité posturale, hypotension orthostatique
- Iatrogénie possible (antihypertenseurs, psychotropes)
- Risques : fracture, dénutrition, fausse route

10 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Maladie de Parkinson

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. P., 72 ans, parkinsonien depuis 8 ans, signale des « blocages » de plus en plus fréquents et deux chutes.

> *PA couché 138/80, debout à 3 minutes 108/66.*

? Quelles évaluations complètent votre analyse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Hypotension orthostatique confirmée (baisse ≥ 20/10 mmHg)
- Agenda des fluctuations (périodes on/off)
- Déglutition, poids, constipation, cognition
- Revue de l'ensemble des traitements

10 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Maladie de Parkinson

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. P., 72 ans, parkinsonien depuis 8 ans, signale des « blocages » de plus en plus fréquents et deux chutes.

> *M. P. veut garder son autonomie.*

? Quel plan de soins proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Avis neurologique pour ajuster le traitement dopaminergique
- Prises à heure fixe ; jamais d'arrêt brutal (vigilance à l'hôpital)
- Hypotension orthostatique : hydratation, lever progressif, contention, revue des antihypertenseurs
- Kinésithérapie, prévention des chutes, orthophonie
- Soutien de l'aidante ; lien avec le centre expert Parkinson

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

V ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Épilepsie et projet de grossesse

Compétences IPA : C1

Sofia, 29 ans, épileptique, traitée par valproate depuis l'adolescence, vient pour son suivi. Elle a un projet de grossesse.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Type d'épilepsie, fréquence des crises, date de la dernière crise
- Traitement, observance, effets indésirables
- Facteurs déclenchants : manque de sommeil, alcool, oublis
- Contraception, projet de grossesse
- Conduite automobile, travail, vécu de la maladie

Raisonnement clinique · IPA PCS

V ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Épilepsie et projet de grossesse

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Sofia, 29 ans, épileptique, traitée par valproate depuis l'adolescence, vient pour son suivi. Elle a un projet de grossesse.

Pas de crise depuis 3 ans ; contraception orale.

? Quels risques identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Valproate : tératogène majeur (malformations, troubles neurodéveloppementaux)
- Ne jamais arrêter brutalement le traitement (risque de crises)
- Interactions de certains antiépileptiques inducteurs avec la contraception hormonale
- Acide folique à prévoir avant la conception

Raisonnement clinique · IPA PCS

V ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Épilepsie et projet de grossesse

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Sofia, 29 ans, épileptique, traitée par valproate depuis l'adolescence, vient pour son suivi. Elle a un projet de grossesse.

Elle ignore les risques liés au valproate.

? Que vérifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Suivi spécialisé et formulaire annuel d'accord de soins
- Test de grossesse en cas de doute
- Contraception efficace jusqu'au changement de traitement
- Rendez-vous rapide avec le neurologue

Raisonnement clinique · IPA PCS

V ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Épilepsie et projet de grossesse

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Sofia, 29 ans, épileptique, traitée par valproate depuis l'adolescence, vient pour son suivi. Elle a un projet de grossesse.

Sofia veut « tout faire bien ».

? Quel accompagnement proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Information claire, sans culpabilisation
- Changement de traitement par le neurologue avant la conception
- Acide folique en préconceptionnel, selon prescription
- ETP : hygiène de vie, conduite à tenir en cas de crise pour l'entourage
- Coordination neurologue, sage-femme ou gynécologue, médecin traitant

Raisonnement clinique · IPA PCS

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

D ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Anticoagulants oraux

Compétences IPA : C1

M. F., 81 ans, sous apixaban pour une FA, vient pour son renouvellement. Ses gencives saignent.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Indication, molécule, dose, horaires, observance
- Saignements : localisation, fréquence ; selles noires, hématurie
- Chutes, cognition (gestion du traitement)
- AINS, antiagrégants, automédication
- Poids, dernière fonction rénale

Raisonnement clinique · IPA PCS

D ♥

D ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Anticoagulants oraux

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. F., 81 ans, sous apixaban pour une FA, vient pour son renouvellement. Ses gencives saignent.

Poids 58 kg, créatininémie 125 µmol/L. Il prend de l'ibuprofène pour ses genoux.

? Comment analysez-vous la situation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Saignements mineurs, risque hémorragique majoré (âge, AINS, rein)
- Apixaban dans la FA : dose réduite si 2 critères sur 3 (≥ 80 ans, ≤ 60 kg, créatinine ≥ 133 µmol/L)
- Ici 2 critères : vérifier la posologie avec le prescripteur
- Interaction AINS-anticoagulant : à arrêter

Raisonnement clinique · IPA PCS

D ♦

D ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Anticoagulants oraux

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. F., 81 ans, sous apixaban pour une FA, vient pour son renouvellement. Ses gencives saignent.

Pas de signe de gravité ; pas d'hémoglobine récente.

? Quels examens et évaluations réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- NFS, clairance de la créatinine (Cockcroft-Gault pour les AOD)
- Scores HAS-BLED et CHA_2DS_2-VASc
- Examen bucco-dentaire ; saignement occulte si anémie
- Risque de chute, cognition

Raisonnement clinique · IPA PCS

D ♣

D ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Anticoagulants oraux

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. F., 81 ans, sous apixaban pour une FA, vient pour son renouvellement. Ses gencives saignent.

La posologie est réduite par le cardiologue.

? Quel plan de suivi proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Arrêt des AINS ; paracétamol, mesures non médicamenteuses
- ETP : signes d'alerte, carte de porteur, information des soignants
- Fonction rénale au moins une fois par an, plus souvent si DFG bas
- Ne jamais arrêter seul ; conduite en cas d'oubli
- Lien avec le pharmacien (entretiens pharmaceutiques AOD)

Raisonnement clinique · IPA PCS

D ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

R ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Polymédication et iatrogénie

Compétences IPA : C1

> *Mme M., 85 ans, prend 11 médicaments. Elle est plus somnolente et a chuté la semaine dernière.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Liste exhaustive : ordonnances, automédication, compléments, collyres
- Qui prépare les médicaments ? Pilulier, compréhension
- Introductions ou modifications récentes
- Somnolence, confusion, chutes, constipation, vertiges
- Fonction rénale, poids, hydratation

Raisonnement clinique · IPA PCS

R ♥

R ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Polymédication et iatrogénie

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme M., 85 ans, prend 11 médicaments. Elle est plus somnolente et a chuté la semaine dernière.

> *Un hypnotique, un antihistaminique et un antidépresseur tricyclique ont été ajoutés successivement.*

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Effet indésirable : charge anticholinergique et sédative élevée
- Cascade de prescription
- Médicaments potentiellement inappropriés (liste de Laroche, critères STOPP/START)
- Différentiels : infection, déshydratation, hyponatrémie, AVC

Raisonnement clinique · IPA PCS

R ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Polymédication et iatrogénie

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme M., 85 ans, prend 11 médicaments. Elle est plus somnolente et a chuté la semaine dernière.

> *Pas de fièvre. Elle boit peu.*

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Ionogramme (natrémie), créatinine et DFG, glycémie
- Hypotension orthostatique
- Globe urinaire, fécalome (anticholinergiques)
- Bilan de la chute : traumatisme, capacité à se relever

Raisonnement clinique · IPA PCS

R ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Polymédication et iatrogénie

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme M., 85 ans, prend 11 médicaments. Elle est plus somnolente et a chuté la semaine dernière.

> *Mme M. et sa fille veulent « alléger » le traitement.*

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Révision avec le médecin et le pharmacien (bilan partagé de médication)
- Déprescription progressive des sédatifs et anticholinergiques
- Hygiène du sommeil, hydratation, activité
- Plan de prise actualisé, partagé avec tous les soignants
- Réévaluation à 2–4 semaines ; pharmacovigilance si effet grave

Raisonnement clinique · IPA PCS

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Patient polypathologique : parcours

Compétences IPA : C1

M. G., 76 ans, diabétique, insuffisant cardiaque et en MRC stade 3, vit seul. Il a été hospitalisé trois fois cette année.

? Quelles données recueillez-vous pour une évaluation globale ?

REPÈRES ATTENDUS

- Pathologies, traitements, priorités du patient
- Autonomie, cognition, humeur, nutrition
- Logement, aides, entourage, ressources
- Intervenants et circulation de l'information
- Motifs des hospitalisations

Raisonnement clinique · IPA PCS

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Patient polypathologique : parcours

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. G., 76 ans, diabétique, insuffisant cardiaque et en MRC stade 3, vit seul. Il a été hospitalisé trois fois cette année.

Les hospitalisations suivent des oublis de traitement.

? Quels problèmes prioritaires identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Observance difficile : isolement, traitement complexe
- Fragilité : risques de perte d'autonomie, de chute, de dénutrition
- Défaut de coordination entre intervenants
- Risque élevé de réhospitalisation

Raisonnement clinique · IPA PCS

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Patient polypathologique : parcours

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. G., 76 ans, diabétique, insuffisant cardiaque et en MRC stade 3, vit seul. Il a été hospitalisé trois fois cette année.

Il dit : « Je ne sais plus qui fait quoi. »

? Quelles évaluations complètent votre analyse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Repérage cognitif, dénutrition, risque de chute
- Ionogramme, DFG, HbA1c
- Bilan partagé de médication
- Cartographie des intervenants et des aides

Raisonnement clinique · IPA PCS

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Patient polypathologique : parcours

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. G., 76 ans, diabétique, insuffisant cardiaque et en MRC stade 3, vit seul. Il a été hospitalisé trois fois cette année.

M. G. souhaite rester à domicile.

? Comment organisez-vous le parcours ?

REPÈRES ATTENDUS

- Plan personnalisé de coordination en santé partagé avec le patient
- Traitement simplifié, pilulier, passages infirmiers
- Dispositif d'appui à la coordination (DAC), aides à domicile
- Télésurveillance de l'insuffisance cardiaque
- Indicateurs : réhospitalisations, qualité de vie (amélioration des pratiques)

Raisonnement clinique · IPA PCS

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

JOKER

JOKER 1



Drapeau rouge

Choisissez une situation du jeu et citez au moins deux signes d'alerte qui imposent une orientation urgente.

Si le groupe valide, ce joker remplace n'importe quelle carte manquante d'un carré.

JOKER

JOKER

JOKER 2



Leadership & recherche

À partir de la dernière situation jouée, proposez une action d'amélioration des pratiques (protocole, audit, formation) ou formulez une question de recherche (PICO).

Compétences C5 · C6. Si le groupe valide, ce joker remplace une carte manquante d'un carré.

JOKER

Aide-mémoire · les couleurs

Chaque couleur est une étape du raisonnement.

♥ **Cœur · Recueillir**
Anamnèse, écoute, contexte de vie

♦ **Carreau · Repérer & hypothèses**
Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges

♣ **Trèfle · Vérifier**
Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels

♠ **Pique · Agir & suivre**
Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Un **carré** (les 4 couleurs d'une même valeur) = un raisonnement complet sur un même patient.

Aide-mémoire · les thématiques

Chaque valeur suit un même patient à travers les 4 étapes.

2	Diabète de type 2 : pied diabétique
3	Diabète de type 1 : hypoglycémies
4	Maladie coronaire stable
5	Insuffisance cardiaque
6	Artériopathie des membres inférieurs
7	AVC : prévention secondaire
8	Insuffisance respiratoire chronique
9	Maladie d'Alzheimer : repérage et suivi
10	Maladie de Parkinson
V	Épilepsie et projet de grossesse
D	Anticoagulants oraux
R	Polymédication et iatrogénie
A	Patient polypathologique : parcours

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PCS

IPA · Master